

的夹角为 $(104.08 \pm 4.41)^\circ$ 、与PY为 $(101.29 \pm 3.51)^\circ$ 、与PZ之间的夹角为 $(76.23 \pm 5.03)^\circ$ 。使用双螺钉时,进针点E与原单螺钉的进针点之间的距离为 (5.12 ± 1.37) mm,进针点F与原单螺钉的进针点之间的距离为 (3.88 ± 0.94) mm;两进针点的连线与长轴方向之间的夹角为 $(27.41 \pm 3.51)^\circ$ 。
结论 最优化计算机辅助解剖测量是一种非常有效的新技术,克服了传统手工实物解剖测量的很多缺点,并且方便设计新的解剖测量参考体系和临床手术方案的制定。

关键词: 肩胛骨; 关节盂; 螺钉; 计算机辅助测量; 最优化方法; 解剖学

经腓骨前方外入路治疗 Gustilo III 型胫腓骨远端骨折

许桦

杭州市萧山区第一人民医院

摘要: **目的** 介绍经腓骨前方的前外侧入路, I期内固定腓骨+II期内固定胫骨治疗Gustilo III型胫腓骨远端骨折的方法并初步探讨其疗效。**方法** 2007年-2010年我院骨科共收治病人4例, 男3例, 女1例, 年龄29岁-51岁, 平均40.1岁。所有病人I期急诊清创后钢板内固定固定腓骨, 外固定支架跨踝关节固定胫骨, 所有病人均出现胫骨前方皮肤坏死或缺损, 经植皮成活后拆除外固定架, 二期采用经腓骨前方入路固定胫骨。根据骨折有无缺损取自体髂骨植骨。早期行功能锻炼, 观察骨折愈合情况及踝关节功能恢复情况。**结果** 随访8个月-3年, 平均21月。4例均获得骨性愈合, 平均愈合5个月。4例均无钢板断裂及螺钉松动。按照美国足踝外科协会(AOFAS)制定的足一踝评分系统评价, 优1例, 良2例, 中1例, 优良率75%。**结论** 对于Gustilo III型开放性胫腓骨骨折, 早期的创伤处理开放伤闭合后, 采用经腓骨前方入路切开复位固定胫骨, 暴露安全, 复位质量高, 内固定可靠, 能促进骨折愈合, 早期解放踝关节, 提高疗效的有效方法。

关键词: 胫腓骨远端骨折; Gustilo III 型; 经腓骨前方入路; 早期锻炼

四肢韧带样纤维瘤的综合治疗

张春雷 海国栋 王勤 窦浚峰 张景义 王军

郑州市骨科医院骨肿瘤骨病II科

摘要: **目的** 探讨四肢软组织韧带样纤维瘤外科手术配合药物治疗效果。**方法** 自2008年6月至2014年1月, 治疗18例四肢韧带样纤维瘤患者, 男7例, 女11例; 年龄10~31岁, 平均19岁。部位分别是臀部2例, 大腿3例、小腿5例、足踝部3例, 前臂3例, 腕部2例。18例中2例行单纯病灶边缘切除, 16例按手术方式分两组, 广泛切除组(10例), 扩大切除组(6例)。术后均常规服用选择性雌激素受体调节剂(他莫昔芬)和NSAIDs(塞来昔布)。观察术后复发情况, 采用Enneking功能评分对术后恢复情况进行评定。**结果** 18例患者均获随访, 时间11~62个月, 平均36个月, 未发现转移。复发6例, 2例为单纯病灶边缘切除, 3例为广泛切除组, 1例为扩大切除组, 复发率33.3%(6/18)。根据Enneking功能评估标准, 广泛切除组术后 (21.6 ± 3.8) 分, 扩大切除组 (28.3 ± 1.3) 分。广泛切除组优6例, 良4例; 扩大切除组优5例, 良1例。**结论** 扩大切除加药物治疗组较广泛切除加药物治疗组功能恢复更好, 由于韧带样纤维瘤不会危及生命, 因此在不牺牲肢体主要功

能的前提下根治性扩大切除加药物治疗可优先考虑。

关键词：韧带炎纤维瘤；药物治疗；外科手术；复发

髋关节囊减压联合同种异体骨打压植骨治疗非创伤缺血性股骨头坏死护理措施

郑艳梅

郑州市骨科医院骨肿瘤骨病Ⅱ科，河南郑州 450052

摘要：目的 总结近4年来106例（114髋）的临床资料，对其护理措施进行评价。方法 2009年8月至2013年8月，对106例（114髋）ARCO II-A、II-B、II-C、III-A期非塌陷性股骨头坏死的治疗应用了髋关节囊切开减压、髓芯减压、病灶刮除、同种异体松质骨打压植骨术，术前做好心理疏导，围术期预防血栓和指导功能锻炼，术后饮食习惯和康复锻炼。结果 随访1.5~4年，按Harris标准其优良率为81.5%。Harris评分由术前平均60分增加到术后4年时的平均88分。结论 髋关节囊切开联合髓芯减压、病灶刮除、同种异体松质骨打压植骨术治疗早中期缺血性股骨头坏死具有良好的疗效，为保头治疗提供一种微创手段，有效、安全、全方位的护理干预取得较好疗效的有力保证。

髋关节囊减压联合同种异体骨打压植骨移植治疗非创伤缺血性股骨头坏死临床观察

海国栋 张春雷

郑州市骨科医院骨病骨肿瘤Ⅱ科

摘要：目的 总结近4年来106例（114髋）髋关节囊减压联合同种异体骨打压植骨治疗非创伤缺血性股骨头坏死的临床资料，对其疗效进行评价。方法 2009年8月至2013年8月，对106例（114髋）ARCO II-A、II-B、II-C、III-A期非塌陷性股骨头坏死的治疗应用了髋关节囊切开减压、髓芯减压、病灶刮除、同种异体松质骨打压植骨术。结果 随访1.5~4年，按Harris标准其优良率为81.5%。Harris评分由术前平均60分增加到术后4年时的平均88分。结论 髋关节囊切开联合髓芯减压、病灶刮除、同种异体松质骨打压植骨术治疗早中期缺血性股骨头坏死具有良好的疗效，为保头治疗提供一种微创手段。

关键词：缺血性股骨头坏死；关节囊；减压；打压植骨；同种异体骨移植